抑郁症

知识类别：疾病与健康知识
资料来源：默沙东诊疗手册・大众版（病人教育资料，逐字转载）
来源 URL：https://www.msdmanuals.cn/home/mental-health-disorders/mood-disorders/depression
获取日期：2026-10-20

以下为逐字转载的原文内容：

抑郁症
抑郁症是一种悲伤、空虚或易怒的感觉，当其强度足以干扰功能时，会变成一种疾病。
病因和风险因素 |
症状 |
筛查 |
诊断 |
治疗 |
了解更多信息 |
多媒体 |
遗传因素、药物副作用、造成精神痛苦的事件、体内激素水平或其他物质水平改变以及很多其他因素可引发抑郁。
遗传因素、药物副作用、造成精神痛苦的事件、体内激素水平或其他物质水平改变以及很多其他因素可引发抑郁。
抑郁可使人悲伤和懒怠并 / 或失去对本来喜欢的事情的兴趣和乐趣。
抑郁可使人悲伤和懒怠并 / 或失去对本来喜欢的事情的兴趣和乐趣。
医生根据体征和症状进行诊断。
医生根据体征和症状进行诊断。
抗抑郁药物、心理治疗，有时还有电休克疗法，都可能有所帮助。
抗抑郁药物、心理治疗，有时还有电休克疗法，都可能有所帮助。
（另请参阅 心境障碍概述 。）
抑郁症是第二常见的精神疾病（ 焦虑 是最常见的精神疾病）。约有 13% 的初级保健医生接诊的患者符合重度抑郁症的诊断标准。
抑郁症通常在青少年中期、20 多岁或 30 多岁时出现，但几乎任何年龄都可能发病，包括儿童时期（另见 儿童和青少年抑郁症及心境调节障碍 ）。
抑郁症患者如果不接受治疗，典型的抑郁发作大约可持续 6 个月，或 2 年甚或更长时间。复发率高，并可多次发作。
人们经常用“抑郁”一词来形容由悲痛性事件（如自然灾害、重病或亲人死亡）导致的悲伤或沮丧情绪。有些人也会在一些特定的时间声称自己感觉抑郁，如每逢节假日时（假日忧郁症）或遇到亲人的祭日时。然而，这样的感情一般不代表疾病。通常，这些悲伤、沮丧和失望的感觉是暂时的，持续数天而不是数周或数月，并且呈波浪式出现，往往与对令人痛苦事件的回忆或提醒有关。此外，这些感受不会长时间影响日常工作和生活。
老年化专题：抑郁症
老年化专题：抑郁症
抑郁症影响许多老年人。有些老年人曾在早年患过抑郁。其他则在老年时首次出现抑郁。 老年人抑郁

症的成因 抑郁的某些原因在老年人中更为多见。例如，老年人经历令人情绪痛苦的事件的可能性更高，比如失去亲爱的人或失去熟悉的家庭环境（如搬离熟悉的周围环境时）。其他可诱发抑郁的应激因素也增加，如收入减少、慢性疾病加重、因逐渐脱离原有的亲友或生活圈而变的性格孤僻。 能够诱发抑郁的疾病在老年人中很常见。此类疾病包括 癌症 、 心肌梗死 、 心力衰竭 、 甲状腺疾病 、 卒中 、 痴呆 和 帕金森病 。 抑郁症与痴呆症 对于老年人，抑郁症可导致类似于痴呆的症状：思考减缓、注意力降低、思维混乱及记忆困难，而非人们通常认为的与抑郁症相关联的悲伤。但医生可区分抑郁症和痴呆，这是因为当治疗抑郁症时，患者精神状态正常。痴呆患者不这样。另外，抑郁患者可能会痛诉记忆力下降，但极少忘记重要的当前事件或私人事件。相反，痴呆患者常否认有记忆力下降。 老年人抑郁症的诊断 老年抑郁的确诊较难，可能的原因如下： 由于老年人可能不再工作或社会活动减少，抑郁症状较难被及时发现。 有些老年患者认为抑郁症是个弱点而羞于告诉周围的人他们所经历的悲伤或其他症状。 老年人的情感缺失常被误认为冷漠。 抑郁症患者的家人和朋友可能将抑郁症状误认为是衰老的正常表现。 这些症状可能被归因于其他疾病，例如痴呆。 由于以上各种原因导致老年抑郁症难以被及时发现，因此医生在诊断该病时需要向老年患者询问许多与情绪相关的问题。家人应警惕患者的性格改变，尤其是变得冷漠、缺乏自发性、幽默感丧失和新发的健忘症状。

抑郁症影响许多老年人。有些老年人曾在早年患过抑郁。其他则在老年时首次出现抑郁。

老年人抑郁症的成因

抑郁的某些原因在老年人中更为多见。例如，老年人经历令人情绪痛苦的事件的可能性更高，比如失去亲爱的人或失去熟悉的家庭环境（如搬离熟悉的周围环境时）。其他可诱发抑郁的应激因素也增加，如收入减少、慢性疾病加重、因逐渐脱离原有的亲友或生活圈而变的性格孤僻。

能够诱发抑郁的疾病在老年人中很常见。此类疾病包括 癌症 、 心肌梗死 、 心力衰竭 、 甲状腺疾病 、 卒中 、 痴呆 和 帕金森病 。

抑郁症与痴呆症

对于老年人，抑郁症可导致类似于痴呆的症状：思考减缓、注意力降低、思维混乱及记忆困难，而非人们通常认为的与抑郁症相关联的悲伤。但医生可区分抑郁症和痴呆，这是因为当治疗抑郁症时，患者精神状态正常。痴呆患者不这样。另外，抑郁患者可能会痛诉记忆力下降，但极少忘记重要的当前事件或私人事件。相反，痴呆患者常否认有记忆力下降。

老年人抑郁症的诊断

老年抑郁的确诊较难，可能的原因如下：

由于老年人可能不再工作或社会活动减少，抑郁症状较难被及时发现。

由于老年人可能不再工作或社会活动减少，抑郁症状较难被及时发现。

有些老年患者认为抑郁症是个弱点而羞于告诉周围的人他们所经历的悲伤或其他症状。

有些老年患者认为抑郁症是个弱点而羞于告诉周围的人他们所经历的悲伤或其他症状。

老年人的情感缺失常被误认为冷漠。

老年人的情感缺失常被误认为冷漠。

抑郁症患者的家人和朋友可能将抑郁症状误认为是衰老的正常表现。

抑郁症患者的家人和朋友可能将抑郁症状误认为是衰老的正常表现。

这些症状可能被归因于其他疾病，例如痴呆。

这些症状可能被归因于其他疾病，例如痴呆。

由于以上各种原因导致老年抑郁症难以被及时发现，因此医生在诊断该病时需要向老年患者询问许多与情绪相关的问题。家人应警惕患者的性格改变，尤其是变得冷漠、缺乏自发性、幽默感丧失和新发的健忘症状。

抑郁症的病因和风险因素

尽管引起抑郁症的确切病因仍不清楚，但目前发现以下几种因素可能与其发病有关。危险因素包括

家族患病倾向（遗传）

家族患病倾向（遗传）
悲痛性事件，特别是涉及亡故的事件
悲痛性事件，特别是涉及亡故的事件
女性
女性
某些一般医学疾病
某些一般医学疾病
某些药物的副作用
某些药物的副作用
抑郁并不反映性格弱势或缺乏努力变好的尝试。社会阶层、种族和文化似乎并不会影响一个人在一生之中罹患抑郁症的几率。
遗传因素在大约三分之一到一半的抑郁症患者中起作用。例如，抑郁症在抑郁症患者的兄弟姐妹、父母和子女（尤其是同卵双胞胎）中更为常见。遗传因素可能通过影响沟通神经细胞间相互联系的物质（神经递质）表达而发挥作用。5-羟色胺、 多巴胺 、 去甲肾上腺素 、谷氨酸和乙酰胆碱是可能与抑郁症有关的神经递质。
其他因素包括调节甲状腺、肾上腺和垂体的激素系统；能够激活或抑制某些基因的环境因素，例如反复的童年创伤；以及重大的生活应激事件，例如失去亲人。
女性比男性更容易发生抑郁，但原因尚不明确。不过，躯体因素中的激素水平是最为相关的因素。激素水平变化可能会在月经即将开始前（作为 经前期综合征 的一部分）、妊娠期和分娩后以及绝经期引起心境变化。在妊娠期间或产后最初 4 周内，有些女性会出现抑郁（称作产后忧郁，如果更严重的话，则称作 产后抑郁症 ）。甲状腺功能的异常在女性中发病率高，也可能是一个致抑郁症发生因素。
跨性别者和非二元性别者的抑郁症发病率似乎高于顺性别者。
心境障碍也可能与季节性变化有关。例如，很多人到了深秋时节和冬季会感到更加悲伤，并将此归咎为日照时间的缩短和气温的降低。不过，在有些人中，这种悲伤情绪会非常严重，足以被视为抑郁（称为季节性情感障碍）。
多种一般疾病和因素可伴随或导致抑郁。这些疾病可直接导致抑郁（比如当 甲状腺疾病 影响激素水平时），也可间接导致抑郁（比如当 类风湿性关节炎 导致疼痛和残疾时）。通常，一种疾病直接或间接诱发抑郁。例如，晚期人类免疫缺陷病毒（HIV）感染可能会损害大脑并直接导致抑郁症。较轻的 HIV 感染也可能通过对患者生活产生整体负面影响（从确诊到感染晚期）而间接导致抑郁症。
有些处方药如某些 β 受体阻滞剂（治疗高血压的药物）可导致抑郁。由于未知原因，当身体因某种疾病（例如 库欣综合征 ）而大量产生类固醇（也称为皮质类固醇或糖皮质激素）时，类固醇常常会导致抑郁症；但当作为药物给药时，它们往往会导致 轻躁狂 （一种较轻的躁狂形式），极少数情况下会导致 躁狂症 。有时，停用某种药物可导致暂时性抑郁。
多种精神疾病可增加一个人的抑郁倾向。很多精神疾病同时可以诱发抑郁，如某些 焦虑障碍 、 酒精使用障碍 、其他 物质使用障碍 和 精神分裂症 。本病常易复发。
情绪困扰的事件，如失去亲人和长期逆境，如欺凌、社会经济压力和不良的童年经历，有时会引发抑郁。然而，抑郁症通常只见于易患该病的人群，如家庭成员有抑郁症的患者。抑郁症也可能在没有任何明显或重大生活应激的情况下出现或加重。
抑郁症的病因
抑郁症的病因
常见病因
常见病因
举例

举例
神经系统疾病
神经系统疾病
脑肿瘤 痴呆 （早期） 头颅外伤 多发性硬化症 帕金森病 睡眠呼吸暂停 中风 影响颞叶的癫痫发作（ 局灶性颠痫发作 ）
脑肿瘤
痴呆 （早期）
头颅外伤
多发性硬化症
帕金森病
睡眠呼吸暂停
中风
影响颞叶的癫痫发作（ 局灶性颠痫发作 ）
癌症
癌症
癌症全身转移（转移癌） 胰腺癌
癌症全身转移（转移癌）
胰腺癌
结缔组织疾病
结缔组织疾病
系统性红斑狼疮 （狼疮）
系统性红斑狼疮 （狼疮）
内分泌系统疾病
内分泌系统疾病
艾迪生病 库欣综合征 糖尿病 甲状旁腺激素水平升高（ 甲状旁腺功能亢进 ） 甲状腺激素水平降低或升高（ 甲状腺功能减退 或 甲状腺功能亢进 ） 垂体功能下降（ 垂体功能减退症 ） 睾酮 水平低（ 性腺功能减退 ）
艾迪生病
库欣综合征
糖尿病
甲状旁腺激素水平升高（ 甲状旁腺功能亢进 ）
甲状腺激素水平降低或升高（ 甲状腺功能减退 或 甲状腺功能亢进 ）
垂体功能下降（ 垂体功能减退症 ）
睾酮 水平低（ 性腺功能减退 ）
感染
感染
人类免疫缺陷病毒（HIV）感染 流行性感冒 单核细胞增多症 梅毒 （晚期） 结核病 病毒性肝炎 病毒性 肺炎
人类免疫缺陷病毒（HIV）感染
流行性感冒
单核细胞增多症
梅毒 （晚期）
结核病
病毒性肝炎

病毒性 肺炎
心境障碍 以外的精神疾病
心境障碍 以外的精神疾病
反社会型人格障碍 焦虑障碍 边缘型人格障碍 早期 痴呆 精神分裂症 物质使用障碍
反社会型人格障碍
焦虑障碍
边缘型人格障碍
早期 痴呆
精神分裂症
物质使用障碍
营养失调
营养失调
糙皮病 （维生素 B6 缺乏） 恶性贫血 （一种维生素 B12 缺乏症）
糙皮病 （维生素 B6 缺乏）
恶性贫血 （一种维生素 B12 缺乏症）
其他疾病
其他疾病
冠状动脉疾病 纤维肌痛 肾衰竭 肝功能衰竭
冠状动脉疾病
纤维肌痛
肾衰竭
肝功能衰竭
药物、物质和非法药物
药物、物质和非法药物
饮酒 安非他命脱瘾 两性霉素B 抗精神病药 β 受体阻滞剂（部分） 甲氰咪胺 避孕药（口服） 类固醇（有时称为皮质类固醇或糖皮质激素） Cycloserine 激素（ 雌激素 或孕酮）疗法 干扰素 汞剂 甲基多巴 甲氧氯普胺 利血平 铊 长春碱 长春新碱
饮酒
安非他命脱瘾
两性霉素B
抗精神病药
β 受体阻滞剂（部分）
甲氰咪胺
避孕药（口服）
类固醇（有时称为皮质类固醇或糖皮质激素）
Cycloserine
激素（ 雌激素 或孕酮）疗法
干扰素
汞剂
甲基多巴
甲氧氯普胺
利血平
铊
长春碱

长春新碱
抑郁症的症状
抑郁症的临床症状通常经过几天或几周逐渐出现，表现多样。比如有的抑郁症患者以行动迟缓和心境低落为主，而有些则表现为易激惹和焦虑不安。
很多抑郁症患者不能正常体验某些情绪，包括悲痛、高兴和快乐。世界在他们眼中似乎黯淡无色、毫无生气。他们对本来喜欢的事情失去兴趣和乐趣。
抑郁症患者可能会专注于强烈的内疚感和自贬，而且可能无法集中注意力。他们可能会感觉绝望、孤独及无价值。患者常表现得犹豫不决、沉默寡言，有很强的无助感和无望感，甚至会想到死亡和 自杀 。
大多数抑郁患者存在入睡困难、反复觉醒，尤其早上更加明显。部分抑郁症患者睡觉比平时多。
伴随抑郁而出现的食欲下降和体重减轻可导致消瘦，女性可出现停经。但是轻度抑郁可以出现进食过量和体重增加。
有些抑郁患者忽视个人卫生，甚至也忽视孩子、其他亲人或宠物的卫生。有些抱怨有躯体不适，存在这样那样的疼痛。
重度抑郁症
重度抑郁症（以前称为单相抑郁症）患者在至少两周的大部分时间里都处于抑郁状态。具体症状包括情绪低落、体重减轻或增加、疲劳、睡眠障碍、躁动或动作迟缓、无价值感或内疚感、思维困难以及自杀意念或行为。他们满眼泪水，眉毛紧蹙，嘴角下拉。而且可能会垂头丧气，并避免眼神接触。他们可能很少活动，面部表情极少，言语单调无生气。
您知道吗……
您知道吗……
抑郁不仅仅是每天情绪低落：患者可能有很强的无价值感和自责，对平常的爱好丧失兴趣，有睡眠障碍或体重增加或减轻。
抑郁不仅仅是每天情绪低落：患者可能有很强的无价值感和自责，对平常的爱好丧失兴趣，有睡眠障碍或体重增加或减轻。
抑郁不仅仅是每天情绪低落：患者可能有很强的无价值感和自责，对平常的爱好丧失兴趣，有睡眠障碍或体重增加或减轻。
持久性抑郁症
持久性抑郁症患者大多数时间都情绪低落，持续 2 年或更长时间。
症状逐渐出现，通常始于青春期，可持续数年或数十年。这些症状包括情绪低落、疲劳、食欲改变、睡眠障碍、躁动或动作迟缓、自卑、绝望感和思维困难。不同时间的症状数量并不相同，有时症状比重度抑郁症轻。
患有这种疾病的人可能情绪低落、悲观、多疑、缺乏幽默感且吹毛求疵。有些消极被动、无精打采以及不与人交往。有些不停地抱怨，动不动就指责别人或责备自己。他们可能过度关注自己的能力不足、失败和负性事件，有时甚至从自己的失败中享受到病态的乐趣。
经前焦虑症
多数月经前都出现重度症状，并在月经结束后消失。症状导致显著痛苦并 / 或严重影响社会功能。症状类似于 经前期综合征 但比它更严重，可导致显著的痛苦并影响工作和社交。
经前焦虑症可在月经初潮后的任何时间出现。它可随着停经的邻近而加重，但在停经后消失。它发生于大约 1-6% 的有月经女性。
经前焦虑障碍患者表现为情绪波动不稳，突然就伤心流泪。她们易被激惹，也容易生气。她们可感到非常沮丧、无望、焦虑和紧张。有些感到几乎要崩溃或失控。
与其他类型抑郁症相同，经前焦虑障碍女性可对自己的惯常活动失去兴趣，难以集中精力，感觉疲乏和无精打采。她们可能会过度进食，并特别想吃某些食物。她们可能睡眠很少或很多。

也可能出现身体症状，如关节疼痛、腹胀感、乳房压痛或体重增加。
延长哀伤障碍
延长哀伤是指失去亲朋好友之后持续悲伤。与抑郁的不同之处在于，这种悲伤与亲朋好友去世有关，而不是与抑郁相关的较普遍的悲伤和失败感。
当悲伤（表现为持续渴望或向往和/或执着于死者）持续很长时间（至少 12 个月），在大量时间中体验到悲伤，并且悲伤程度比当事人所在的文化所认为的典型程度更深时，就被视为存在延长哀伤。它还必须伴随以下 3 项或以上至少 1 个月，达到导致痛苦或失能的程度：
感觉身份混乱（例如，感觉自己的一部分已经死亡）
感觉身份混乱（例如，感觉自己的一部分已经死亡）
对死亡持怀疑态度
对死亡持怀疑态度
回避让人想起亲朋好友去世的事物
回避让人想起亲朋好友去世的事物
强烈的情感痛苦（例如，与死亡相关的痛苦）
强烈的情感痛苦（例如，与死亡相关的痛苦）
难以继续生活
难以继续生活
麻木感
麻木感
无意义的感觉
无意义的感觉
强烈的孤独
强烈的孤独
其他与抑郁症相关的疾病和状况包括物质滥用以及罹患癌症和心血管疾病的风险增加。
物质使用
抑郁症患者可能常试图通过饮酒或使用非法药物缓解入睡困难或焦虑情绪。但是，抑郁症导致的 酒精使用障碍 和其他 物质使用障碍 比想象得要少。
另外，抑郁的患者也更容易大量吸烟并忽视自己的健康。所以，他们出现其他疾病（如 慢性阻塞性肺疾病 ）或导致其他疾病加重的风险也会升高。
抑郁症的其他影响
抑郁症可能会降低免疫系统对外来或危险的侵袭性病原体（如微生物或癌细胞）的反应能力。因此，抑郁症患者更容易感染。
抑郁症会增加心血管疾病（如心脏病发作）和卒中的风险。这可能是因为抑郁症会导致某些身体变化，从而增加这种风险。例如，身体产生了更多帮助血液凝固的物质（凝血因子），而且心脏针对不同情况改变心率的能力降低。
抑郁症筛查
医生可能让患者填写标准化调查问卷用于诊断抑郁症和评定它的严重程度，但不能单纯依靠它们来诊断抑郁症。其中两个问卷是 患者健康问卷-9（PHQ-9）和 Beck 抑郁症量表 。对于老年人，可使用 老年抑郁量表 问卷。医生常会询问被调查人是否有伤害自己的想法或计划。如果患者确实存在这样的想法则说明其存在严重的抑郁障碍。
抑郁症的诊断
医生根据标准精神病诊断标准进行评估
医生根据标准精神病诊断标准进行评估
做检查来发现其他可能导致抑郁的疾病

做检查来发现其他可能导致抑郁的疾病
医生一般根据症状即可诊断抑郁症。医生使用特定的症状（标准）列表，诊断不同类型的抑郁症。为了帮助区分抑郁症与心境的普通变化，医生判断症状是否会导致严重痛苦或损害患者的功能。既往抑郁病史或家族史有助于确诊。
由于过度的焦虑、惊恐发作和强迫在抑郁症中很常见，常易使医师误诊为 焦虑障碍 。
老年人的抑郁症可能不容易发现，特别是当他们没有工作或很少参加社交活动时（参见 老年化专题：抑郁 ）。另外，由于抑郁症与 痴呆 具有相似的症状，比如意识模糊、难以集中精力和思维不清晰等，所以抑郁症可能会被误认为痴呆。不过，如果这些症状是由抑郁症导致，它们会在抑郁症得到治疗后消退。如果是由痴呆导致，则不会消退。
检查
没有什么检查可以确诊抑郁症。不过，实验室检查可帮助医生确定患者的抑郁是否由激素疾病或其他躯体疾病导致。例如，医生通常会做血液检查以排除 甲状腺疾病 或 维生素缺乏 。可以进行检查以发现非法药物使用。
全面的 神经系统检查 可帮助排除与抑郁症具有一些相同症状的 帕金森病 。
睡眠受到严重干扰的患者可能需要进行睡眠检查（ 多导睡眠图 ），明确患者的 睡眠障碍 是否与抑郁相关。
抑郁症的治疗
支持
支持
心理治疗
心理治疗
使用药物，主要是 抗抑郁药
使用药物，主要是 抗抑郁药
有时进行电休克治疗或经颅磁刺激
有时进行电休克治疗或经颅磁刺激
多数抑郁症患者采取非住院治疗方式，但有些患者必须住院接受相应治疗。尤其是那些有严重自杀企图或曾有自杀行为，或有明显体重减轻，或由于严重激越而产生心脏疾病的患者。
治疗依抑郁的程度和类型而异：
轻度抑郁：支持治疗（包括频繁就诊和宣教）和心理治疗
轻度抑郁：支持治疗（包括频繁就诊和宣教）和心理治疗
中重度抑郁：药物和/或心理治疗，有时可采用电休克治疗
中重度抑郁：药物和/或心理治疗，有时可采用电休克治疗
季节性抑郁：光疗
季节性抑郁：光疗
延长哀伤障碍：针对该疾病制定的心理治疗
延长哀伤障碍：针对该疾病制定的心理治疗
抑郁通常能够治愈。若能找到具体原因（比如某一药物或疾病），应先纠正这些原因，不过仍有可能需要使用抗抑郁药物。
支持
医生向抑郁患者及其家人解释抑郁症存在生理原因，需要专门的治疗，而这些治疗通常有效。医生安慰患者及其家人，抑郁症并不代表性格缺陷。家庭成员了解疾病并参与治疗提供支持是很重要的。
了解有关抑郁症的知识可帮助患者理解并应对该病。例如，患者可以了解到康复的路上常常困难重重，悲伤情绪和绝望念头可能会重现但最终会消失。如此一来，患者即可正确地看待任何挫折，并更有可能坚持治疗，不中途放弃。

多做运动—经常散步和锻炼—可有帮助，多跟人接触也有帮助。
互助团体（如抑郁症和双相障碍支持联盟—— DBSA ）可为患者提供一个分享共同经历和感受的平台，以此来帮助患者。
心理治疗
对于轻度抑郁而言，单纯心理治疗即可达到与药物治疗相同的效果。当与药物结合使用时，心理治疗对重度抑郁症有效。
个体或小组心理治疗可帮助抑郁患者逐渐恢复以往的社会功能，适应正常的生活压力。人际关系治疗着重于患者过去和当前的社会角色，找出患者在待人接物方面存在的问题，指导患者适应生活角色的变化。认知行为疗法可以帮助改变绝望和消极的想法。正念疗法（将自我意识融入认知行为疗法）和精神动力疗法（侧重于无意识冲突和童年早期经历）是用于治疗抑郁症的其他心理疗法。
治疗抑郁症的药物
有几类可用的 抗抑郁药 （参见表格 治疗抑郁症的药物 ）。它们包括：
选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRI)
选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRI)
选择性 5-羟色胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂 (SNRI)
选择性 5-羟色胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂 (SNRI)
5-羟色胺调节剂（5-HT 2 阻滞剂）
5-羟色胺调节剂（5-HT 2 阻滞剂）
去甲肾上腺素-多巴胺再摄取抑制剂
去甲肾上腺素-多巴胺再摄取抑制剂
杂环抗抑郁药
杂环抗抑郁药
单胺氧化酶抑制剂 (MAOI)
单胺氧化酶抑制剂 (MAOI)
褪黑剂类抗抑郁药 （阿戈美拉汀）
褪黑剂类抗抑郁药 （阿戈美拉汀）
精神兴奋剂
精神兴奋剂
氯胺酮和艾司氯胺酮
氯胺酮和艾司氯胺酮
电休克治疗
电休克疗法（过去有时被称为电击疗法）有时用于治疗重度抑郁症患者，包括伴有精神病症状的患者，以及有自杀倾向或拒食的患者。它也可以用于治疗怀孕且无法使用药物治疗的抑郁症患者。
不同于抗抑郁药物需要服用数周后才能起效，电休克治疗可以快速、有效的缓解抑郁症状。因而可以及时挽救病人的生命。电休克治疗停止后，抑郁可能会复发。为防止复发，医生常给患者开抗抑郁药物。
在电休克治疗过程中，电极被置于头部，产生的电流通过颅内诱发一次抽搐发作。这种抽搐发作可以缓解抑郁，但其作用机制目前还不清楚。通常至少需要进行 6 至 10 次治疗（隔天一次）。
由于电流会引起肌肉收缩和疼痛，治疗期间需要短暂的全身麻醉。电休克治疗可能引起短暂的记忆缺失，极少情况为永久性记忆丧失。
光疗
光疗（光疗灯箱）对季节性抑郁症最为有效，但用于其他类型的抑郁症也会有帮助。
光疗的方法是，患者坐在一个灯箱前方一定远处，接受灯箱发出的足够强度的光线。患者被告知不能直视光线，需要在光线前方坐 30 至 60 分钟。光疗可以在家进行。

如果患者晚睡晚起，光疗在早上最有效，有时在下午 3 点至 7 点之间补充 5 至 10 分钟的照射。如果患者早睡早起，光疗在下午晚些时候至傍晚早些时候最有效。

其他疗法

精神兴奋剂， 有时也用于治疗抑郁症，如右旋苯异丙胺和哌甲酯及其他的一些药物。精神兴奋剂被用来提高精神警醒程度和觉察。

圣约翰草 是一种草药膳食补充剂，有时用于缓解轻度至中度抑郁症，但研究尚未证实其对治疗重度抑郁症有效。由于圣约翰草可以与许多处方药物产生相互作用并对人体有害，因此打算服用此类草药及其提取物的患者在服用前需要向自己的医师明确其是否与在服的其他药物有相互作用。

当初始治疗无效时，可以尝试刺激大脑的其他疗法。它们包括

重复经颅磁刺激

重复经颅磁刺激

迷走神经刺激

迷走神经刺激

深部脑刺激

深部脑刺激

受刺激的细胞被认为可以释放化学信使（神经递质），有助于调节人的情绪，从而可能减轻抑郁症的症状。这些疗法可以帮助那些对药物或心理治疗无反应的严重抑郁症患者。

重复经颅磁刺激 是将一个电磁线圈靠近前额放置，据认为此处接近涉及调节情绪的大脑区域。电磁铁产生无痛的磁脉冲，医生认为可以刺激大脑目标区域的神经细胞。最常见的副作用是头疼和线圈放置位置附近的头皮不适。

迷走神经刺激 是指，一个看起来像心脏起搏器的装置（迷走神经刺激器）被植入左锁骨下，并通过一根在皮肤下延伸的导线与颈部的迷走神经相连。（迷走神经从脑干发出，位于颅底附近，穿过颈部并向下沿着胸腹部两侧到达心脏和肺等器官。） 该装置可进行编程，以使用无痛电信号定期刺激迷走神经。当其他治疗无效时，它可能有效，但通常需要 3 至 6 个月才能生效。迷走神经刺激的副作用包括声音嘶哑、咳嗽和神经刺激时声音加深。

深部脑刺激 使用植入式电极来刺激大脑中负责情绪调节和与情绪相关的自动生物反应的特定区域，已取得令人鼓舞的成果。

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。

抑郁症和双相障碍支持联盟 (DBSA)，抑郁症

抑郁症和双相障碍支持联盟 (DBSA)，抑郁症

美国心理卫生协会 (MHA)，抑郁症

美国心理卫生协会 (MHA)，抑郁症

全国心理疾病联盟 (NAMI)，抑郁症

全国心理疾病联盟 (NAMI)，抑郁症

国家精神卫生研究所 (NIMH)，抑郁症

国家精神卫生研究所 (NIMH)，抑郁症